



NYHEDSBREV FRA
Støtteforening for Hospicearbejde



April 2025





Fra venstre: Jørn Kaltoft Nielsen, næstformand, Keld Andersen, suppleant, Linda Jensen, formand, Susanne Andreasen, kasserer, Ellen Jørgensen, bestyrelsesmedlem, Kirsten Hansen, sekretær, Niels Aaskov-Hansen, bestyrelsesmedlem.

Forside: Skulptur af Joan Artigas Planas, Barcelona, Skænket af Støtteforening for Hospicearbejde Fyns 20 års jubilæum 2024

KELD ANDERSEN – SUPPLEANT I BESTYRELSEN

Støtteforening for Hospicearbejde

JUBILÆUMSGAVE TIL HOSPICE FYN

Hospice Fyn havde i oktober måned 2024 20-års jubilæum.

I oktober 2004 fejrede man indvielsen af Hospice Fyn med meget stort fremmøde, hvor daværende Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen holdt hovedtalen ved 1. spadestik i 2003.

"Støtteforeningen for hospicearbejde" blev stiftet på en generalforsamling i marts 1999 og havde sidste år 25års fødselsdag, som vi fejrede med lagkage til generalforsamlingen.

Støtteforeningen har gennem alle årene støttet Hospice Fyn med midler og var selvfølgelig inviteret med til Hospice Fyns 20 års jubilæumsfest d. 1. november 2024 på Odd Fellow Palæet.

En fantastisk humørfuld festaften, hvor begge bestyrelser for Hospice og Støtteforeningen, ledelse og personale samt frivillige etc. ved Hospice Fyns deltog. Under festlighederne blev der afholdt gaveoverbringelse, taler, sange og sågar danset kædedans til musik af et oplagt orkester "John Mogensen Tribute".

Støtteforeningens "kunstudvalg" havde været rundt på forskellige gallerier og fundet en skulptur af Joan Artigas Planas, som blev overbragt under festligheder af 2 medlemmer Niels Aaskov-Hansen og Keld Andersen fra bestyrelsen.

Joan Artigas Planas er spanioler og født i 1960, bor og arbejder i Barcelona, hvor han også underviser på Kunsthøjskolen i Barcelona.

Skulpturens er af kunstneren navngivet "Watching The Life". Vi synes at både navnet og skulpturens udseende passer fantastisk til stedet.

Skulpturen står til daglig i receptionen til Hospice Fyn.

Tillykke med jubilæet og tak til festudvalget for en dejlig aften.



Har du lyst til at være en af støtterne, er du meget velkommen i Støtteforening for Hospicearbejde. Indmeldelse til Sekretariat: E-mail: sekretariat@hospicefyn-sf.dk

Støtteforening for Hospicearbejde

HVAD HAR VI STØTTET I 2024

Støttet i alt	kr.	kr.	kr. 336.700
Frivillige		57.600	
Kørsel	31.300		
Møde/Kursus	1.500		
Udflugt	16.800		
Kontantkasse	8.000		
Personale		84.600	
Uddannelse	49.000		
Konference Barcelona	16.700		
Kongress	18.900		
Blomster mm		144.600	
Pasning af planter	71.000		
Buketter m.m.	28.600		
Pasning/Renovering af fiskebassin	37.000		
Kontantkasse	8.000		
Øvrige		49.900	
Abonnementer avis/blade m.m.	22.000		
Forplejning pårørende	17.300		
Gave 20-års jubilæum	10.600		
Tilskud i alt til Børn/Unge OUH			kr. -60.100
Sorggruppe forældre - sygt barn	-36.500		
Sorggruppe søskende	-23.600		

EACP

2024

I maj måned 2024 pakkede tre personer fra Hospice Fyn deres kufferter og fløj til Barcelona for at deltage i EACP 2024 kongres.

EACP - European Association for Palliative Care afholdes årligt og er stærkt repræsenteret World Wide. Vi fulgte flere sessions, og blev

præsenteret for den palliative forskning, både igangværende og endelige resultater. Danmark er "godt" med, når det handler om den specialiserede palliative indsats. Flere lande præsenterede flere digitale løsninger både for den sygdomsramte, samt for de pårørende, bl.a. *Grief Support guide* og *My path*.



Digitale løsninger som kan støtte og hjælpe de efterladte, når de har mistet.

Grief-Support-Guide_Eng3-Nov-23.pdf
MyPath – The digital solution to patient-centred cancer care (mypath-cancercare.eu)

Fælles beslutningstagen og samtaleredskabet Avance Care Planning, ACP (på dansk - FPB – Fremtidig pleje og behandling) blev også præsenteret fra flere vinkler, og kan med fordel inkludere familier i samtalen. En samtale, hvor der tales om ønsker, tanker og håb i den sidste tid. I samtalen er der fokus på patientens autonomi. Samtalen udføres allerede på Hospice Fyn, mundtlig men ikke digitalt, som den bliver i andre lande og som et vigtigt element meget tidligere i sygdomsforløbet. Den følger patienten i sygdomsforløbet og er et dynamisk dokument, som kan ændres undervejs. Det viste sig, at patienterne tog stilling i ro og mag, følte mere ejerskab og det gav mere livskvalitet hos både patienten selv og de pårørende. Forskningen viste også at den digitale løsning, var med til at skabe åbenhed, håb, trykthed og nye snakke omkring den sidste tid.

Kunstig intelligens blev også diskuteret, tænkt højt og kommenteret. Hvordan man som sundhedsprofessionel positivt kan anvende det, hvordan man fremadrettet skal forholde sig. Det blev italesat, at det på ingen måde kan erstatte de "varme hænder", men kan med fordel anvendes i teknologien og ved udredning og behandling.

Som sundhedsprofessionel skal man vænne sig til tanken, at det bliver en del af hverdagen i fremtiden.

En spændende rejse i forskningens verden, hvor der dannes netværk på tværs af lande og kontinenter, der videns deles og reflekteres sammen, alle med samme formål, nemlig at styrke den palliative indsats.

Det var en givende oplevelse både fagligt og tværfagligt. I 2025 afholdes EACP i Helsinki, hvor Hospice Fyn sender to personer.

Tak for Jeres tid og af hjertet tak for Jeres støtte. Det er med til at gøre at Hospice Fyn er opdateret med nyeste viden og tiltag indenfor palliationens verden.

*Kærligst Marlene udviklingssygeplejerske,
Hospice Fyn*

About us - EAPC (eapcnet.eu)

AF SYGEPLEJERSKE STINE LANGDAL

Bronzeengle på Hospice Fyn

Støtteforeningen gjorde det muligt, at bronzeenglen i august 2024 flyttede ind på Hospice Fyn. Der er indtil nu udleveret engle til bl.a. Flemming og 30 andre patienter og pårørende.

Hans øjne er store og fyldt med angst. Flemming har lige været på toilet. Nu sidder han på sin rullator og foran ham på bordet har jeg serveret en kop kaffe med fløde og masser af sukker til ham. Han har ilt i næsen, men har alligevel svært ved at få luft og hiver efter vejret. Sveden løber stille fra panden og ned ad kinderne på ham. Flemming får en kold klud på panden og én i nakken. Jeg ser hans flakkende blik, lægger min hånd i hans og tilbyder ham mit nærvær. Langsomt finder han ro igen og får luften tilbage.

Flemming har prøvet det mange gange før. Han har nemlig KOL og oplever flere gange dagligt, ikke at kunne få luft. Det bliver udløst af hverdagsting som at gå på toilet, vaske sig, spise og flytte sig fra A til B. Oplevelsen af ikke at kunne få luft og angst går ofte hånd i hånd. Også for Flemming. Han forklarer mig senere, at han, under sådan et anfald, har mange tanker der går gennem hovedet på ham: "Dør jeg nu?", "hvordan skal jeg klare mig?", "jeg bliver mere og mere hjælpeløs?" og "er livet værd at leve?". Da Flemming igen har fået vejret kigger han på mig, smiler, klemmer min hånd og siger: "Jeg klarede det. Nu kan jeg få luft igen". Han slipper min hånd og nipper til sin kaffe. Han er træt. Det er hårdt at have sådan et anfald. Både fysisk

og psykisk. Jeg smiler tilbage og bekræfter: "Ja, du klarede det."

Jeg tager en bronzeengel op af lommen. Jeg rækker den til ham og siger: "Jeg har noget til dig, hvis du vil have den". Flemming kigger op: "Tak", siger han forbløffet og rækker hånden ud. En tåre triller ned af kinden på ham, imens han studerer englen: "Der er ikke så tit nogen, som giver mig gaver".

Vi får en snak om tro, trøst, håb og afmagt. Vi bliver enige om at englen er en livshjælp





Englekasse

og en beskytter i en hverdag, der ikke altid er lige let og et håb om, at vi ikke er alene. Englen bliver for mig et redskab til at tale om den åndelige/eksistentielle dimension. Det kan være en hjælp at kunne give noget konkret i situationer præget af lidelse, dødsangst, uro, ensomhed og afmagt, hvor ord og/eller medicin ikke slår til.

Englen står på natbordet eller ligger i Flemmings brystlomme resten af tiden, han er på hospice. Og da han bliver udskrevet til plejehjemmet og alt er pakket ned tager han sig til brystlommen og siger: Jeg har det hele med".

Ordet "engel" stammer fra det latinske "angelus", som betyder "budbringer" eller "sendebud". Englen som symbol er rummelig og bredt anvendelig. Den kan komme med budskaber som fx "frygt ikke". Den kan være anledning til at tale om tro, trøst, håb, afmagt, kærlighed og mening og kan for mennesker, lige som Flemming, der skal igennem svære tider og tilbage til hverdagen, opleves som en livshjælp.

Englen har den styrke, at den ikke er knyttet til en bestemt religion eller verdensanskuelse. Englen findes i kristendommen, islam, jødedommen og de fleste andre religioner. Englen er desuden transcendent – den overskrider en grænse, som vi ikke kan. Man kan sige, at engle har fulgt menneskene gennem alle tider. Ud over at være symbol med alt, hvad det kan rumme, så er bronze-englen konkret – den ligger godt og tungt i hånden, kan være god at gribe ud efter, når man ellers ikke ved, hvad man skal gribe til, og man oplever, at ens verden vakler. Når den har ligget i hånden et stykke tid, bliver den varm og overtager ens egen kropstemperatur.

Tusind tak for at gøre det muligt for os på Hospice Fyn at udlevere bronzengle til både patienter og pårørende som trøst og støtte i en betydningsfuld og svær tid.

Flemming er et opdigtet navn (pga. tavshedspligt) til en virkelig patient på Hospice Fyn.

OVERLÆGE MARTIN LEHRMANN BOESEN

Med børnelægen på arbejde

I DET BØRNE- OG UNGE PALLIATIVE TEAM

06:30

Vækkeuret ringer. Mandag morgen og hele familien skal i gang.

Heldigvis bor vi tæt på OUH, så der er ikke lang transport på arbejde. Pendlerlivet har jeg prøvet, og det er ikke prisværdigt for familien.

07:40

Min datter og jeg cykler afsted sammen. Skolen og OUH ligger praktisk talt på samme matrikel – indtil videre. Nyt OUH varsler jo flytning, men indtil videre er mine bønner blevet hørt, og vi er fortsat ikke flyttet til stor glæde for mig og familielogistikken.

08:00

Hver mandag morgen har vi tværfaglig konference i teamet. Så bruger vi 2 timer på at gennemgå de familier vi har tilknyttet teamet. Vi arbejder ud fra Total Pain modellen hvor man ser på både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle udfordringer i familien. Det sikre at vi kommer hele vejen rundt om alle de problemstillinger der måtte være i en familien med et døende barn.

I teamet er vi 2 sygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 social rådgiver, 1 præst, en koordinator for frivillige, 2 læger samt en psykolog – desværre er vores psykologstilling aktuelt sparet væk. Vi er alle halvtids ansat, så vi har samtidig alle en anden

ansættelse på OUH også. Med så mangfoldig en faglig sammensætning kan teamet give et bredt input til Total Pain modellen omkring familierne.

10:00

Den tværfaglige konference er slut og jeg overtager læge telefonvagten fra min kollega. Vi skiftes til at have vagt en uge ad gangen. De ca. 40 familier som er tilknyttet Børne- og Unge Palliativt Team i Region Syddanmark, har alle vores vagt-nummer hvor de døgnet rundt kan få fat på enten min kollega eller mig. I de familier hvor vi har tilknyttet hjemmesygeplejersker kan hjemmesygeplejersken også ringe til os. Tilbuddet skaber i høj grad tryghed for familierne, så forældrene tør være hjemme i eget hjem med deres døende barn. Især i de familier hvor barnet er nær døden er det en vigtig hjælp for familierne.

10:30

Opkald til en sagsbehandler i en kommune til en snak om bevilling af en handicapbil til en familie, hvor deres dreng har en genetisk sygdom. Han er født rask, men har siden indskolingen mistet færdigheder. Drengen er nu multihandicappet. Kommunen og vi ser ikke helt ens på sagen og vi har afgivet en partshøring på et afslag. Jeg forhører mig om sagen vil blive omstødt af kommunen selv, eller sendt til ankestyrelsen. Hvis sagen skal i ankestyrelsen, kan det desværre tage lang tid før der kommer en afgørelse, og i ventetiden må



familien klare sig uden det ansøgte. Jeg får desværre ikke svar på min forespørgsel, da rette vedkommende ikke er der. Bagefter ringer jeg til familien. De bliver kede af udsigten til ventetid.

For mange af vores familier er det en stor omvæltning pludseligt ikke at kunne klare sig selv, men at skulle spørge deres kommune om rigtig mange ting. Det fratrækker en stor del af deres autonomi. Du kan f.eks. ikke bare flytte til et andet hus, hvis du ønsker at det skal indrettes til dit handicappede barn. Hvis kommunen skal hjælpe dig, skal de f.eks. godkende din bolig først. Og skal en handicapbil bevilges, kan der kan være flere års ventetid på levering.

11:00

Nyt opkald til en mor for at høre hvordan det går med deres barn. Barnet er svært handicappet p.g.a iltmangel ifbm. fødslen. Drengen er svært skadet og det er hårdt for forældrene og søskende. Jeg snakker med mor om hvordan vi kan støtte familien aktuelt. Der er høj grad af Total Pain i familien: Drengen har nogle problemer med slim hvilket er klassisk når man har nedsat hostekraft og det øger risikoen for lungebetændelser hvilket kan være livstruende for et svært handicappet barn. Forældrene er trætte p.g.a. dårlig søvn, psykisk udmattet p.g.a. kampen med kommune omkring støtte til pasning af drengen og socialt

udfordret fordi søskende i familien mistrives da forældrene er udmattede. Eksistentielt er de også truet fordi de ikke lever op til deres egne principper, ønsker og håb.

11:30

Nyt opkald til en familie med et handicappet barn på baggrund af en genetisk sygdom. Han er også født normalt men over kort har han tabt færdigheder og nu er han i kørestol og har behov for hjælp til alt. Vi snakker om nogle af de tiltag der er behov for i den kommende tid. Forløbet har været hurtigt og det har været svært for os, familien og kommunen at være på forkant med udviklingen. Vi enes om at et ophold på et børnehospice er en god ide. Der findes to børnehospice i Danmark. Vi bruger dem ikke kun til livets afslutning, men også som aflastning for familier i palliativt regi, hvor de ansatte på hospice ligeledes ud fra Total Pain principperne arbejder hele vejen rundt om familierne.

12:00

Det er tid til at køre på hjemmebesøg. En af sygeplejerskerne og jeg kører af sted ud til en af de familier som har et barn med terminal kræftsygdom og er tilknyttet teamet. Vi skal mødes derude med hjemmesygeplejersken som kommer dagligt i hjemmet. Teamet har mødetid 08 til 15.24, derudover kan vi kontaktes på vagtelefonen men ikke møde op fysisk. Vi er derfor afhængig af hjemmesygeplejersker hvis der er nogen der skal møde op i hjemmet hos en familie tilknyttet teamet. Region Syddanmark



er en geografisk stor region så et hjemmebesøg kan tage mange timer hvis familien bor nær den tyske grænse. I dag skal vi dog ikke så langt. Hos familien går det rimeligt, og de klarer det godt på trods af den vanskelige situation de står i. Livskrisen som forældre er uendelige og samtidig skal de håndtere alle de praktiske ting der er når man har et svært sygt barn hjemme. Men de fleste børn vil gerne være hjemme i deres sidste tid og det ønske vil forældrene gøre alt for at opfylde. Enkelte gange kan det ikke lade sig gøre og der er hospice en et godt sted at være – få børn dør på hospitalet.

14:30

Hjemme igen fra besøget. Tid til lige at skrive notatet. Desuden er der kommet nogle SMS'er fra nogle af de familier vi har i teamet. Vi kommunikerer ofte med familierne via sms hvis ikke det er noget akut. Det giver en stor grad af frihed for familierne. En enkelt af beskederne kræver en opringning. Resten klarer jeg på sms. Laver recepter til dem der mangler og følger op på beskeder i vores elektroniske patient journal. Da jeg er halvt tid i palliation og halv tid i reumatologi er der også nogle beskeder derfra som skal håndteres i dag.

16:00

Tid til at hente børn og komme hjem ad.

17:30

Jeg laver aftensmad til familien. Undervejs kom-

mer der et opkald fra en familie hvor barnet hoster mere end vanligt og ikke kan komme af med sin slim pga. kendt nedsat hostekraft. Vi enes om at give barnet ekstra inhalationer og bruge hoste maskinen – begge udstyr som de har i hjemmet.

18:40

Kører en af vores børn til svømning og handler ind på vejen hjem.

Tilbage igen putter jeg den mindste.

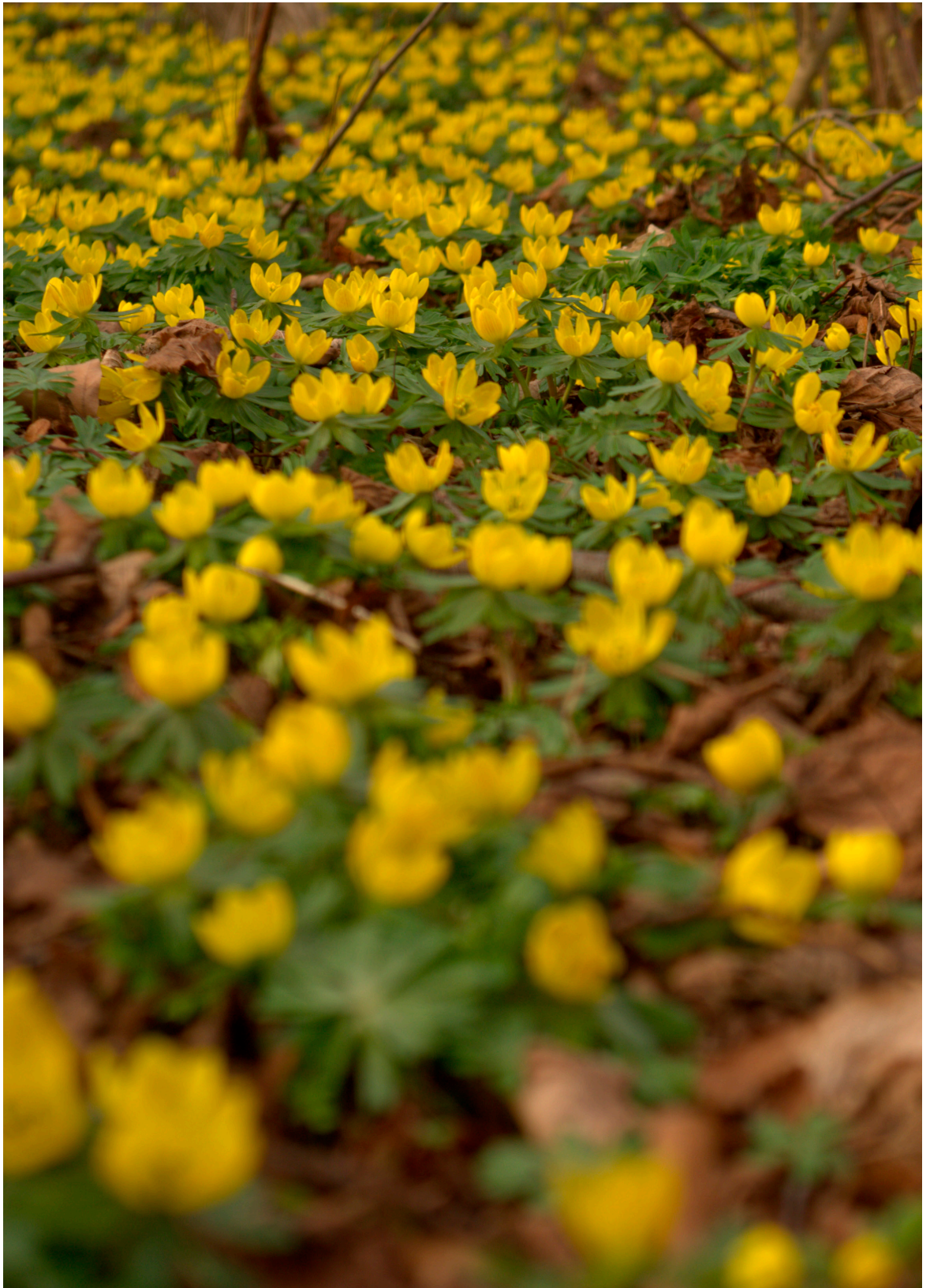
21:00

Hente i svømmehallen igen. De korte bilture er en god mulighed for at snakke sammen uforstyrret.

22:00

Tid til at sove. Der har ikke været flere opkald så forhåbentligt kan jeg sove uforstyrret.

*Overlæge Martin Lehrmann Boesen H.C.
Andersen Børne- og Unge Hospital, Region Syd*





ELISABETH ROKKJÆR HAMMER CAND.TEOL.

Sorg og kærlighed i det palliative felt

"SORG ER KÆRLIGHEDENS PRIS"

"Sorg er kærlighedens pris" er en sætning vi nok alle er stødt på gennem de sidste mange år. Alle, der har mistet et elsket menneske ved, hvordan kærlighed og sorg hører uløseligt sammen. Derfor sendes både børn, unge og voksne ud på en sorgvandring, når de rammes af en uhelbredelig sygdom og ikke mindst deres familier skal til at finde vej i sorgens mange landskaber. Der opstår mange tab undervejs i et sygdomsforløb. Sorgen kan fylde meget, for der er så meget og mange vi kan have kærlighed til her i livet, og som det er så smertefuldt at måtte tage afsked med. På sorgvandringen hen mod døden kan man føle sig meget alene med sin sorgfuldhed.

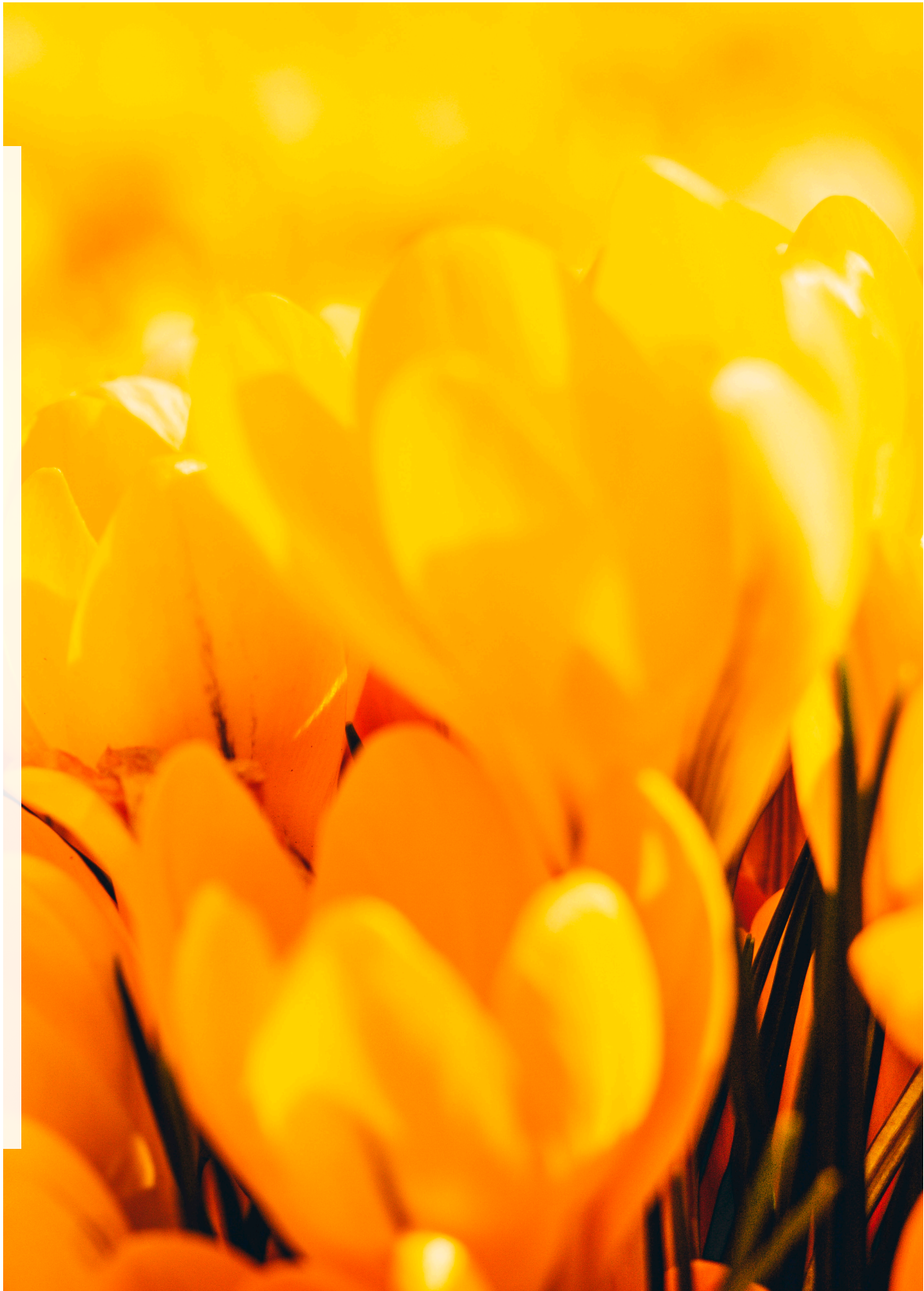
I fredags var jeg så heldig at være med til premiere på filmen *"Min evige sommer"*. Filmen handler om en ung kvinde på 16 år, Fanny, der skal miste sin mor. Filmen skildrer på fineste vis, hvordan Fanny kæmper med sorgens mange ansigter. Filmen beskriver den ensomhed, der opstår når et ungt menneske ikke oplever fællesskaber, hvor det bliver set og lyttet til. Forældrene i familien er gode og kærlige forældre, men det er svært at finde ordene, så de kan være fælles om sorgen. I stedet blive de alene med hver deres sorgfuldhed.

Sorg kan, som bekendt, ikke fikses med hurtige greb. Sorg skal derimod udtrykkes og deles så

man ikke skal bære sorgens byrde helt alene. Vi lever på mange måder i en "fiksekultur" og i mange dele af tilværelsen er det godt at kunne fikse sagerne, men når vi møder og støtter et ungt menneske i sorg, kræves en anden tilgang. Her skal vi spørge og lytte. Her skal vi vise det unge menneske oprigtig nysgerrighed og interesse. Mange unge udtrykker, at omgivelsernes tavshed er noget af det værste. Vi skal turde spørge mere end en gang og turde lade os afvise, hvis den unge, på det tidspunkt, hellere tale med vennerne om festen på fredag.

I børne- og unge palliativt team er en af vores fornemste opgaver at støtte familien i deres kommunikation, så de kan være sammen om sorgen. Gennem en god kommunikation i familien kan de bevare nærheden. Vi kan ikke fjerne sorgen, men i fællesskabet fødes håbet. Her skal håb ikke forstås som det at lægge dage til den syges liv, men håb, forstået som et eksistentielt håb, hvor vi kan føle at livet kan opleves meningsfuldt og værdifuldt på trods af sorgen.

Elisabeth Rokkjær Hammer Cand.teol., Master i Sjølesorg og hospitalspræst ved Palliativt Team og Børn og Unge Palliativ Team, Odense Universitets Hospital



Støtteforening for Hospicearbejde



Støtteforening for Hospicearbejde · Hjemmeside: **www.hospicfyn-sf.dk**

Husk venligst at meddele adresseændring til:
Kasserer Susanne Andreasen · Snekstrup Have 37, st. tv. · 5210 Odense NV
e-mail: sga1952@hotmail.com